原发性血脂异常体质类型及其与血脂指标相关性研究*

韩丽蓓[1] 王丽娟[2] (1北京中医药大学东直门医院 北京100700;2北京中医药大学)

摘要:目的 分析原发性血脂异常患者的体质分布特点,以及中医体质类型与血脂指标间的关系。**方法** 收集122例原发性血脂异常患者的一般资料、血脂指标;采用王琦的体质分类方法,将患者分为9种体质类型,使用SPSS 18.0进行统计运算。**结果** 122例原发性血脂异常患者的主要体质类型是气虚质,占61.48%,其次是痰湿质、阴虚质、气郁质及阳虚质,其中,男性的主要体质为气虚质、痰湿质、阴虚质和湿热质;而女性则以气虚质、痰湿质、阴虚质和气郁质最多。低密度脂蛋白(LDL-C)与气虚质、阳虚质呈正相关性,血清载脂蛋白A1(ApoA1)与气郁质呈负相关性。**结论** 气虚质是原发性血脂异常最常见的体质类型;体质类型与血脂指标有一定的相关性。

关键词:原发性血脂异常;体质类型;血脂指标
中图分类号:R259

Constitutional types and correlation between them and blood fat indexes in patients with primary dyslipidemia

HAN Li-bei[1], WANG Li-juan[2] (1 Dongzhimen Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100700; 2 Beijing University of Chinese Medicine)

Abstract: Objective To analyse the distribution characteristics of constitutional types and relationship between TCM constitutional types and indexes of blood fat in the patients with primary dyslipidemia. **Methods** The general materials and indexes of blood fat were collected from 122 patients. All patients were divided into 9 constitutional types by applying Professor WANG Qi's method of constitutional classification, and then the data was calculated by using SPSS 18.0 software. **Results** The constitutional types were mainly qi-deficiency constitution in 122 patients (61.48%), and other types were phlegm-dampness constitution, yin-deficiency constitution, qi-depression constitution and yang-deficiency constitution. In male patients the constitutional types were mainly qi-deficiency constitution , phlegm-dampness constitution, yin-deficiency constitution and damp-heat constitution and in female ones, were mainly qi-deficiency constitution, phlegm-dampness constitution yin-deficiency constitution and qi-depression constitution. The level of low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) was positively correlated to qi-deficiency constitution and yang-deficiency constitution, and the level of apolipoprotein A1 (ApoA1) was negatively correlated to qi-depression constitution. **Conclusion** Qi-deficiency constitution is the most common constitutional type in the patients with primary dyslipidemia, and constitutional types are correlated to indexes of blood fat.

Key words: primary dyslipidemia; constitutional types; blood fat indexes

1 临床资料

选取2009年4月至2011年6月在东直门医院住院的原发性血脂异常患者122例。其中男性54例,女性68例,年龄在45~75岁,平均年龄为(61.71±9.56)岁。

2 方法

2.1 诊断标准

血脂异常诊断标准:依据"中国成人血脂异常防治指南"[1]中的规定,在正常饮食情况下,满足下列4项中的1项或1项以上者诊断成立:①总胆固醇

韩丽蓓,女,硕士,副主任医师,硕士生导师
*北京中医药大学自主选题资助项目

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(TC)≥5.18 mmol/L;②甘油三酯(TG)≥1.7 mmol/L;③高密度脂蛋白(HDL-C)<1.04 mmol/L;④低密度脂蛋白(LDL-C)≥3.37 mmol/L。

中医体质分型标准:参照《中医体质学》[2]中的中医体质分类判定标准,将患者分为9种体质类型。

2.2　纳入标准

①符合血脂异常的西医诊断标准;②年龄在45~75岁;③虽然服用调脂药物,但已经停药2周以上,而且血脂水平仍然符合诊断标准;④知情同意,自愿参加调查,并如实回答调查者的问题。

2.3　排除标准

①半年内曾经患有急性心肌梗死、脑血管疾病、严重创伤或重大手术的患者;②因服用药物(β-阻滞剂、肾上腺皮质类固醇及某些避孕药物等)而引起的血脂异常;③合并肝、肾、造血系统等严重原发性疾病、精神病及心功能不全3级以上者;④由甲状腺功能异常、糖尿病等全身性疾病引起的继发性血脂异常患者;⑤不符合上述纳入标准者。

2.4　观察与统计方法

将患者的临床资料、血脂指标,应用SPSS 18.0进行统计运算,分析出原发性血脂异常患者的体质类型及其与血脂指标的相关性。

3　结果

3.1　原发性血脂异常患者的体质分布情况

122例原发性血脂异常患者中,气虚质最多,显著高于其他体质类型;其次是痰湿质、阴虚质、气郁质、阳虚质。提示:在原发性血脂异常患者的体质分型中,正气虚之体质占主要地位,其中又以气虚质为主;邪气实之体质中,以痰湿质、湿热质和气郁质为多见。54例男性患者中,气虚质最多,其次是痰湿质、阴虚质和湿热质。68例女性患者中,也是气虚质最多,其次是痰湿质、阴虚质和气郁质。见表1。

表1　122例患者体质分布情况比较

体质类型	男性(n=54)		女性(n=68)		总人数(n=122)	
	频数	%	频数	%	频数	%
平和质	2	3.70	3	4.40	5	4.10
气虚质	28	51.90	48	70.60	76	62.30
阳虚质	14	25.90	24	35.30	38	31.15
阴虚质	18	33.30	24	35.30	42	34.43
痰湿质	23	42.60	22	32.40	45	36.89
血瘀质	8	14.80	15	22.10	3	18.85
气郁质	12	22.20	30	44.10	41	33.61
湿热质	16	29.60	10	14.70	6	21.31
特禀质	5	9.30	2	2.90	7	5.74

3.2　体质类型与血脂指标的相关性

运用SPSS 18.0中的有序回归法,统计出LDL-C与气虚质、阳虚质呈正相关性,血清载脂蛋白A1(ApoA1)与气郁质呈负相关性。即LDL-C的值越高,气虚质及阳虚质的可能性越大;ApoA1的值越小,气郁质的可能性越大。见表2、表3、表4、表5。

表2　模型拟合信息

模型	似然值	卡方值	自由度	P
气虚质	205.989	11.971	3	0.007*
阳虚质	238.244	15.516	3	0.001*
气郁质	230.473	15.131	5	0.010*

注:似然值表示模型贡献度,*P<0.05说明气虚质、阳虚质、气郁质有序回归模型可以建立。

表3　气虚质有序回归模型参数估计值

变量		参数估计	标准误	卡方值	自由度	P	95%置信区间	
							下限	上限
阈值(因变量)	气虚质=0	-0.419	0.958	0.192	1	0.661	-2.296	1.457
	气虚质=1	0.699	0.944	0.548	1	0.459	-1.151	2.548
位置(自变量)	LDL-C	0.612	0.238	6.794	1	0.009*	0.154	1.088
	血清载脂蛋白B(ApoB)	-1.837	1.037	3.138	1	0.076	-3.870	0.196

注:非气虚质、倾向气虚质分别赋值为0和1,即气虚质=0、气虚质=1分别表示非气虚质、倾向于气虚质。*P<0.05表示有统计意义。本表LDL-C的P值为0.009,且参数估计为正值,提示:LDL-C与气虚质有正相关性。

表4　阳虚质有序回归模型参数估计值

变量		参数估计	标准误	卡方值	自由度	P	95%置信区间	
							下限	上限
阈值(因变量)	阳虚质=0	-2.829	1.580	3.209	1	0.073	-5.925	0.266
	阳虚质=1	-1.790	1.567	1.305	1	0.253	-4.861	1.281
位置(自变量)	LDL-C	0.915	0.337	7.379	1	0.007*	0.255	1.575
	ApoB	-2.414	1.429	2.855	1	0.091	-5.214	0.386

注:非阳虚质、倾向阳虚质分别赋值为0和1,即阳虚质=0、阳虚质=1分别表示非阳虚质、倾向于阳虚质。*P<0.05表示有统计意义。本表LDL-C的P值为0.007,且参数估计为正值,提示:LDL-C与阳虚质有正相关性。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表5 气郁质有序回归模型参数估计值

变量		参数估计	标准误	卡方值	自由度	*P*	95%置信区间	
							下限	上限
阈值(因变量)	气郁质=0	−2.161	1.788	1.460	1	0.227	−5.665	1.344
	气郁质=1	−1.358	1.782	0.581	1	0.446	−4.851	2.134
位置(自变量)	ApoA1	−1.266	0.581	4.750	1	0.029*	−2.404	−0.127
	ApoB	−2.619	1.462	3.212	1	0.073	−5.484	0.245
	TC	0.500	0.272	3.386	1	0.066	−0.033	1.032
	LDL-C	0.563	0.382	2.174	1	0.140	−0.186	1.312

注:非气郁质、倾向气郁质分别赋值为0和1,即气郁质=0、气郁质=1分别表示非气郁质、倾向于气郁质。*$P<0.05$表示有统计意义。本表ApoA1的P值为0.029,且参数估计为负值,提示:ApoA1与气郁质有负相关性。

4 讨论

血脂异常是临床常见病,是动脉粥样硬化的主要致病因素,已经成为目前的研究重点。本次研究从中医体质、血脂指标两方面入手,对原发性血脂异常进行了研究。从研究结果可以看出,虚性体质中之气虚质、阴虚质,实性体质中之痰湿质、湿热质和气郁质是原发性血脂异常患者的主要病理体质类型。提示本病的病理性质为本虚标实,但以虚性体质为主。推测其病机,由于气虚、阴虚,气化无力,以致水谷精微运化失常,或者气机郁滞,过食肥甘厚味,以致中焦运化失司,痰湿内停,可能是原发性血脂异常患者的主要病理变化。

《普济方》中指出:“男子以阳为主,则阳胜乎阴。”提示生理状态下,阳气相对旺盛;而病理状态下,阳气反易损伤。一旦损伤,则气化无力,易化生痰湿,故男子以痰湿质更多见。又说“女子以阴为主,则阴胜乎阳”,且宋代陈自明《妇人大全良方》更言“妇人以血为基本”。提示生理状态下,女子阴血相对旺盛;而病理状态下,阴血反易损伤。一旦损伤,则不养肝脏,而肝气不能疏达,故女子以气郁质更多见。由此看出,尽管男女有痰湿质与气郁质之别,但是,痰湿质、气郁质之产生均是由于阴阳之不足。说明男女之别,别在阴阳;体质之根,祖于正气。也提示原发性血脂异常的基本病机为“因虚致实”。

LDL-C的升高是动脉粥样硬化发生、发展的主要脂质危险因素。也有研究认为,动脉粥样硬化是一种慢性炎症性疾病,LDL-C可能是这种慢性炎症的始动和维持的基本要素[3]。本次研究显示:正气虚之体质占主要地位,且LDL-C升高与气虚质、阳虚质有关,两者之间存在相关性,从而支持中医认为本病病机是“因虚致实”的论断。ApoA1主要由小肠和肝脏合成,是HDL的主要载脂蛋白,对细胞内胆固醇起清除作用[4]。本次研究提示:ApoA1降低其体质更趋向于气郁质,这可能与“肝克脾土”、肝郁脾虚、生化乏源有关。

本研究在统计体质类型及血脂指标的相关性时采用有序回归法,中医体质判定标准按分值大小将体质分为“是、倾向是、否”3个不同的等级,此种统计方法更适合这种分等级的数据。

由于本次研究收集的样本量较少,对体质类型与血脂指标的相关性研究只作出了部分结果。针对于此,拟在下一步试验时扩大样本量,以期取得更准确和可靠的结果。

参考文献:

[1] 中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(5):394.

[2] 王琦.中医体质学[M].北京:人民卫生出版社,2009:457-466.

[3] 陈敏.血脂与脑梗死的关系[J].上海医学杂志,2004,27(10):772-773.

[4] 祁莉萍,严晓伟.高密度脂蛋白与血管内皮功能保护[J].基础医学与临床,2006,26(12):1397-1400.

(收稿日期:2012-04-01)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net